

Lactancia y manejo inicial del recién nacido

1. Introducción y relevancia clínica

La **lactancia materna (LM)** es el método ideal y natural de alimentación del recién nacido, proporcionando **nutrientes, inmunidad, vínculo afectivo y beneficios de salud a largo plazo**.

La **OMS y el MINSAL** recomiendan **lactancia materna exclusiva (LME)** durante los **primeros 6 meses** de vida y su **mantención complementada hasta los 2 años o más**.

El **manejo inicial del RN**, por su parte, busca **favorecer la adaptación neonatal, prevenir la hipotermia, estimular el apego y garantizar una lactancia eficaz desde la primera hora**.

- En el EUNACOM es muy frecuente encontrar preguntas tipo:
“RN sano en puerpera inmediata, ¿cuál es la conducta más importante? → Contacto piel a piel e inicio precoz de lactancia.”
-

2. Fisiología de la lactancia

Hormonas clave

Hormona	Fuente	Función
Prolactina	Adenohipófisis	Estimula la producción de leche (lactogénesis).
Oxitocina	Neurohipófisis	Produce la eyección láctea (reflejo de bajada).
Estrógenos / progesterona	Placenta	Inhiben lactogénesis durante el embarazo; caen tras el parto, permitiendo inicio de lactancia.

El reflejo de lactancia se mantiene por **succión frecuente**, que estimula la hipófisis materna.

- Cuanto más succiona el RN, más prolactina y oxitocina se liberan → mayor producción de leche.
-

3. Beneficios de la lactancia materna

Para el recién nacido

- Nutrición óptima: composición ajustada a edad y necesidades.
- Protección inmunológica (IgA secretora, lactoferrina, lisozima, macrófagos).
- Reducción de infecciones respiratorias y gastrointestinales.
- Menor riesgo de obesidad, diabetes tipo 1, alergias, y muerte súbita del lactante.
- Mejor desarrollo neurológico y vínculo afectivo.

Para la madre

- Estimula contracción uterina y previene hemorragia posparto (oxitocina).
- Acelera recuperación del peso pregestacional.
- Disminuye riesgo de cáncer de mama y ovario.
- Favorece la amenorrea lactacional (método anticonceptivo natural).
- Refuerza vínculo emocional madre-hijo.

Para la sociedad

- Menor gasto sanitario y contaminación.
 - Favorece salud pública y nutrición infantil.
-

4. Composición de la leche materna

Etapa	Duración	Características
Calostro	1–5 días	Espeso, amarillento, rico en proteínas, anticuerpos e IgA; volumen bajo pero suficiente.
Leche de transición	5–14 días	Aumenta volumen, grasa y lactosa.
Leche madura	>15 días	87% agua, grasa variable según fase (inicio más acuosa, final rica en lípidos).

□ En EUNACOM se pregunta frecuentemente:

“La primera leche amarillenta y espesa rica en inmunoglobulinas es el **calostro**.”

5. Técnica de lactancia adecuada

A. Posición materna y del RN

- Madre cómoda, espalda y brazos apoyados.
- RN alineado (“oreja-hombro-cadera en línea”), abdomen contra abdomen.
- Boca del RN a nivel del pezón.

B. Prensión correcta

- Boca bien abierta, labios evertidos.
- Mentón toca el pecho.
- Nariz libre.
- Más aréola inferior dentro de la boca que la superior.
- Succión lenta, profunda y audible.

C. Signos de buena técnica

- No dolor ni grietas.
 - RN tranquilo, deglute rítmicamente.
 - Pecho se ablanda tras mamada.
 - Aumento de peso y diuresis normal (≥ 6 micciones/día).
-

6. Frecuencia y duración

- A libre demanda, mínimo **8–12 veces al día**.
- No limitar duración (generalmente 10–20 min por mama).
- Ofrecer ambas mamas, alternando el inicio.

☐ El vaciamiento completo de la mama asegura leche rica en grasa → mayor saciedad y ganancia ponderal.

7. Problemas frecuentes y manejo

Problema	Causa	Manejo
Pezones doloridos o agrietados	Mala técnica o prensión superficial	Corregir postura, aplicar leche materna local
Ingurgitación mamaria	Acúmulo de leche, retraso en lactancia	Extracción manual o succión frecuente
Obstrucción ductal	Conducto bloqueado	Masaje local + lactancia continua
Mastitis	Infección por <i>S. aureus</i>	Cloxacilina y continuar lactancia

Grietas persistentes	Mal acople o infección por <i>Candida</i>	Antifúngico tópico (nistatina, miconazol)
Baja producción	Succión infrecuente, estrés	Succión a libre demanda, apoyo emocional

8. Contraindicaciones de la lactancia materna

Absolutas

- Infección materna por VIH (si acceso a fórmula segura, según MINSAL).
- Galactosemia clásica del RN.
- Uso materno de fármacos citotóxicos o radioactivos.
- Consumo activo de drogas ilícitas.

Relativas

- Tuberculosis materna activa no tratada (suspender hasta 2 semanas de tratamiento).
- Lesiones herpéticas en mama (evitar mama afectada).
- Mastitis purulenta o absceso (continuar en mama sana).
- Hepatitis B o C → **no contraindican lactancia.**

□ En EUNACOM: “Madre con hepatitis B puede amamantar si RN recibe vacuna y HBIG.”

9. Manejo inicial del recién nacido sano

A. Inmediato (primeros 5 minutos)

1. **Contacto piel a piel inmediato** (reduce hipotermia y mortalidad neonatal).

2. **Secar y estimular al RN.**
3. **Evaluar respiración y tono (Apgar).**
4. **Pinzar cordón tras 1–3 minutos** (beneficio hematológico).
5. **No aspirar rutinariamente** (solo si hay obstrucción evidente).
6. **Colocar gorro y abrigo** (prevención de hipotermia).

☐ En EUNACOM: “La medida más efectiva para prevenir hipotermia neonatal: contacto piel a piel inmediato.”

B. Primeras horas

- Iniciar lactancia precoz (<1 hora de vida).
 - Administrar **vitamina K1 1 mg IM** (prevención enfermedad hemorrágica).
 - Profilaxis ocular con **eritromicina o tetraciclina** (prevención conjuntivitis neonatal).
 - Control de temperatura, frecuencia cardíaca y respiratoria.
 - Evaluación de malformaciones y peso.
-

C. Primeros días

- Mantener lactancia exclusiva.
 - Controlar ictericia fisiológica (peaks entre 3°–5° día).
 - Pesaje diario (pérdida $\leq 10\%$ peso al nacer es fisiológica).
 - Evaluar micción y deposiciones (debe orinar en primeras 24 h, eliminar meconio en 48 h).
 - Tamizaje metabólico (PKU, hipotiroidismo congénito, fibrosis quística).
-

10. Educación a la madre y familia

Tema	Recomendación
Lactancia exclusiva	Sin agua, té ni fórmula por 6 meses
Sueño seguro	Decúbito supino, sin almohadas ni peluches
Higiene del cordón	Mantener seco, limpieza con agua y jabón si sucio
Control del RN	Dentro de 48–72 h tras el alta
Signos de alarma	Fiebre, rechazo alimentario, ictericia intensa, respiración dificultosa

11. Indicadores de lactancia exitosa

- Ganancia de peso ≥ 150 g/semana.
- Micciones ≥ 6 /día.
- Deposiciones amarillas y blandas.
- RN tranquilo post lactancia.
- Mamas blandas post succión.

☐ “El mejor indicador de lactancia adecuada es la **ganancia ponderal del lactante.**”

12. Políticas y guías nacionales (MINSAL)

- Lactancia exclusiva hasta los 6 meses.

- **Lactancia prolongada hasta los 2 años o más.**
 - **Iniciativa Hospital Amigo del Niño (IHAN):** 10 pasos para fomentar la LM.
 - **Protocolo MINSAL:** apoyo activo desde el parto, alojamiento conjunto, consejería y control precoz post alta.
-

13. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. El **calostro** es rico en IgA, proteínas y carotenoides.
2. El **inicio precoz de lactancia** favorece vínculo, oxitocina y éxito prolongado.
3. La **mejor prevención de hipotermia:** contacto piel a piel.
4. **Continuar lactancia durante mastitis.**
5. **Hepatitis B no contraindica lactancia.**
6. **Misoprostol o fármacos citotóxicos:** sí contraindican.
7. **Ganancia de peso:** mejor indicador de lactancia eficaz.



Errores comunes

- Indicar fórmula en RN con pérdida de peso <10% (fisiológica).
 - Separar madre e hijo tras parto normal.
 - Aspirar rutinariamente secreciones.
 - Usar alcohol en cordón umbilical.
 - Suspender lactancia por mastitis leve o antibiótico seguro.
-

14. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Lactancia materna exclusiva por 6 meses** es la recomendación MINSAL/OMS.
2. **Hormonas clave:** prolactina (producción) y oxitocina (eyección).
3. **Contacto piel a piel e inicio precoz** son las medidas más importantes del posparto inmediato.
4. **Calostro:** primera leche, rica en anticuerpos y nutrientes.
5. **Continuar lactancia durante mastitis**, salvo absceso drenado.
6. **Mejor indicador de eficacia:** ganancia ponderal.
7. **Evitar suplementos innecesarios:** ni agua ni fórmula.